四、并发症（上下班）

规律：
肠道里面刺激肠管→肠鸣音↑
肠道外面刺激肠管→肠鸣音↓

1.上消化道出血：呕血、黑便、肠鸣音↑
铁与硫化氢形成硫化亚铁

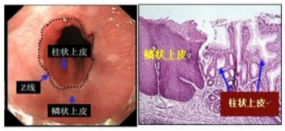
2.食管**狭窄**：除极少数严重瘢痕狭窄需手术治疗外，绝大部分狭窄可行内镜下食管扩张术
反流损伤→肉芽组织对损伤的食管黏膜进行纤维性修复

3.**Barrett 食管**

①食管下部的鳞状上皮被柱状上皮取代（**腺上皮化生**）食管鳞癌不是化生，食管腺癌与化生有关

②食管**腺**癌的癌前病变：需定期接受**胃镜随访**

《病理学》：化生是一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织，通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中，通过正常组织的干细胞等转分化实现





更红，因为食管下部鳞状上皮被柱状上皮（薄）取代，血管透见

五、食管反流监测如电阻抗-pH 监测是诊断胃食管反流病的金标准（明确过度酸碱反流）

天天师兄

可能可能最可能：**反复反流、烧心**，多在**餐后** 1 小时、**卧位**、弯腰加重，站立、坐位减轻，考虑胃食管反流病：

①非糜烂性反流病：**NERD 胃镜食管**表现为**阴**性、**食管反流监测**提示存在反流的客观证据、质子泵抑制剂 PPI 试验性治疗有效 ttsx 看食管黏膜破损情况

②反流性食管炎：**胃镜**是诊断 **RE** 最准确的方法，洛杉矶 LA 分级（我气我）：

A 级	食管黏膜有破损，其长径＜5mm
B 级	食管黏膜有破损，至少有一处长径＞5mm
C 级	食管黏膜有破损，且破损有**融合**、＜75%的食管周径
D 级	食管黏膜有破损，且破损有**融合**、＞75%的食管周径

六、治疗

1.**抑酸药**

（1）**首选**、**最佳**：**质子泵抑制剂 PPI**（奥美/泮托**拉唑**）：与 H^+-K^+-ATP 酶不可逆结合，疗程 4-8 周（酸死吧）

伏特加

（2）**钾离子竞争性酸阻滞剂**（potassium-competitive acid blockers,**P-CAB**）：疗程 4-8 周，**伏诺拉生**与 K^+竞争结合 H^+-K^+-ATP 酶，酸环境稳定、不需酸激活、起效快、持续时间长、夜间作用确切、用药个体差异小和不良反应少

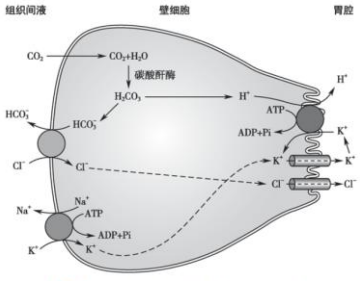


图 6-5　胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图
CO_2 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 H^+ 和 HCO_3^-，H^+ 通过 H^+,K^+-ATP 酶主动转运至分泌小管腔。

（3）**H_2-R 拮抗剂**（法莫/西咪**替丁**）：适合轻、中度患者，疗程 8-12 周（爸盯幺儿）

效应没有PPI/P-CAB强→疗程相对较长